TEMA 5 · Derechos de los usuarios, igualdad y violencia de género. Personal estatutario del SMS

Resumen OPE Enfermería SMS · Bloque A: Derechos y garantías de los usuarios, proceso de muerte, igualdad y violencia de género · Bloque B: Estatuto Marco, Ley 5/2001 y régimen disciplinario

Siglas y leyes de este tema

Sigla o norma	Nombre completo	De qué va
SMS / SNS	Servicio Murciano de Salud / Sistema Nacional de Salud	
AP / AE	Atención Primaria / Atención Especializada	
TSI	Tarjeta Sanitaria Individual	Con ella se asigna enfermera y médico
LO	Ley Orgánica	Ley de derechos fundamentales; necesita mayoría absoluta
Ley 3/2009	Ley de derechos y deberes de los usuarios del sistema sanitario de la Región de Murcia	Bloque A
Ley 41/2002	Ley básica de Autonomía del Paciente (estatal)	Consentimiento, información, instrucciones previas
LO 2/2010 (reformada por la **LO 1/2023**)	Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE)	Aborto
Decreto 25/2006	Decreto murciano de tiempos máximos de espera	150 / 50 / 30 días
Decreto 106/2007	Decreto murciano de segunda opinión médica	
Decreto 80/2005	Decreto murciano de instrucciones previas y su registro	
LORE (LO 3/2021)	Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia	Prestación de ayuda para morir
Ley 7/2007	Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres y de Protección contra la Violencia de Género de la Región de Murcia	A4 y A5
LO 1/2004	Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (estatal)	Solo pareja o expareja
TREBEP (RDLeg 5/2015)	Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público	Normas de todos los empleados públicos
EM (Ley 55/2003)	Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud	Bloque B
Ley 5/2001	Ley de personal estatutario del Servicio Murciano de Salud	Versión murciana del EM
Ley 53/1984	Ley de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas	

Abreviaturas de las normas: **RD** = Real Decreto; **RDL** = Real Decreto-ley (norma urgente del Gobierno con fuerza de ley); **RDLeg** = Real Decreto Legislativo (el Gobierno junta en un solo texto, «refundido», leyes dispersas).

A1. Ley 3/2009: principios, menores e información

Ley 3/2009, de 11 de mayo, de derechos y deberes de los usuarios del sistema sanitario de la Región de Murcia.

- **Principios (art. 7)**: respeto a la dignidad, equidad y corresponsabilidad. **Humanización (art. 8)**: confort y descanso nocturno, acompañamiento (sobre todo fin de vida, menores, dependientes) y trato personalizado (presentarse y llamar al paciente por su nombre).
- **P1000D (Primeros Mil Días; Ley regional 12/2018, que reforma el art. 16 de la Ley 3/2009)**: derechos de los **primeros mil días** = 270 días de gestación + 365 + 365 → **desde la concepción hasta los 2 años**. Garantiza trato digno, **identificación inmediata** (pulseras pareadas, sangre de cordón), **cribado neonatal** y atención temprana.

- **Piel con piel**: inmediato e ininterrumpido, **mínimo 2 horas** si madre y recién nacido están estables. En la **cesárea**: **electrodos del ECG en la espalda** y **manguito de TA en la pierna**, para dejar libres el pecho y los brazos.
- **Información (art. 29)**: 4 áreas: **asistencial**, **epidemiológica**, **planes sanitarios** y **sistema sanitario**. Derecho a **no saber**: libre, expreso y **registrado** en la historia, designando a un tercero.

Edad	Consentimiento (Ley 41/2002)
≥ 16 años o emancipado	Mayoría de edad sanitaria: decide él
Excepciones	**Grave riesgo** para su vida o salud: consiente el **representante legal**, oída la opinión del menor. Ensayos clínicos y reproducción asistida: normativa específica. La interrupción voluntaria del embarazo (**IVE**) a los 16-17 años la consiente la propia menor (LO 1/2023)
< 16 años	Por representación, pero se le **escucha obligatoriamente desde los 12** o si es maduro

- **IVE a petición de la mujer** (LO 2/2010): dentro de las **primeras 14 semanas** de gestación, sin causa médica.
- **Confidencialidad (art. 27)**: cede ante las enfermedades de declaración obligatoria (**EDO**) y brotes, **delitos** (maltrato infantil, violencia de género, sumisión química → **parte judicial de lesiones**) y **mandato judicial**. Si se declara en un juicio (como testigo o perito), solo se cuenta **lo imprescindible**, nunca sin límite.
- **Deberes (arts. 61-63)**: respetar instalaciones y normas, respeto al personal, responsabilidad sobre la propia salud y uso racional.
- **Segunda opinión (Decreto 106/2007 de segunda opinión médica)**: solo en procesos graves (**cáncer**, enfermedades **neurológicas degenerativas**, **enfermedades raras**, **cirugía compleja** de alto riesgo). Plazo: **15 días hábiles**; si se incumple, el paciente puede ir a otro centro a cargo del SMS.

TRAMPAS DE EXAMEN

! P1000D empieza en la **concepción**, no en el parto.

! Segunda opinión: **15 días hábiles**; no procede para una HTA leve o una rotura fibrilar.

A2. Garantías de accesibilidad y libre elección

- **Decreto 25/2006 (tiempos máximos de espera del SMS)**: cirugía **150**, primeras consultas **50**, pruebas **30** días **naturales**. Solo cubre la **demora estructural** (atribuible al SMS); no la que se debe a aplazamiento voluntario, contraindicación clínica temporal o incomparecencia.
- **Libre elección (RD 1575/1993 de libre elección de médico en AP, y art. 17 de la Ley 3/2009)**: en cualquier momento y **sin justificar**, siempre que el profesional tenga el **cupo abierto** y el domicilio conste en la Tarjeta Sanitaria Individual (TSI). Para **menores**, firma de **ambos progenitores**.
- **Civitas Enfermera (2013)**: Murcia, pionera en la **libre elección de enfermera** en AP; su nombre figura en la TSI.
- En AE, la libre elección exige **indicación facultativa previa** (derivación).
- **SIPS (Sistema de Información de Profesionales Sanitarios, Decreto 339/2009)**: registro público de datos profesionales (titulación, especialidad, categoría, centro, diplomas de acreditación).

Cupo máximo de TSI	Tarjetas
Enfermera de AP	**1.800** (todas las edades)
Médico de familia	**1.500** (≥ 14 años)
Pediatra	**1.200** (< 14 años)

TRAMPAS DE EXAMEN

! Aplazar la cirugía por un motivo personal **detiene** la garantía.

A3. Proceso de muerte: instrucciones previas y eutanasia

Instrucciones previas (Decreto 80/2005 de Murcia)

- **Qué son** (Ley 41/2002): documento en el que una persona **mayor de edad, capaz y libre** deja escrita su voluntad sobre los cuidados y el tratamiento para cuando no pueda expresarla, o, tras su muerte, sobre el **destino de su cuerpo o sus órganos**. Se incorpora a la historia clínica y deben respetarlo centros y profesionales.
- Otorgante **mayor de edad, capaz, libre** y no incapacitado judicialmente. Puede nombrar un **representante** (mayor de edad y capaz).
- Tres vías: **notario** (sin testigos, con coste), **funcionario** del Registro de la Consejería (gratis) o **3 testigos** mayores de edad y capaces, de los que **2 no pueden tener parentesco hasta el 2.º grado** ni relación patrimonial, laboral o matrimonial → como máximo **un familiar**.
- Registro murciano conectado al **Registro Nacional**. Revocable y modificable en cualquier momento; prevalece el más reciente.
- **No se aplican** si son contrarias al ordenamiento jurídico, a la **lex artis** (la buena práctica profesional) o no corresponden al supuesto previsto.
- Si un profesional objeta en conciencia o hay **dudas de interpretación**, se consulta al **Comité de Ética Asistencial** del centro (no al Servicio Jurídico; ver tema 3).

Eutanasia: LO 3/2021 de Regulación de la Eutanasia (LORE)

- Prestación de ayuda para morir incluida en la **cartera común** del SNS.
- **Eutanasia**: el profesional **administra** la sustancia. **Suicidio médicamente asistido**: el profesional la prescribe o facilita y el **paciente se la autoadministra**.
- Si quien le da la sustancia es un particular (un amigo) y el paciente se la toma él mismo, fuera de la prestación de la LORE, se habla de **ayuda al suicidio**.
- Requisitos: enfermedad **grave e incurable** o padecimiento **grave, crónico e imposibilitante** con sufrimiento intolerable.
- **Comisión de Garantía y Evaluación de Murcia** (Orden de 20 de mayo de 2021): **11 miembros**: **5 médicos, 3 juristas, 2 enfermeras y 1 farmacéutico**. Evalúa antes y revisa después.
- **Objeción de conciencia**: **individual**, anticipada y **por escrito** ante la gerencia. La **institución no puede objetar**: el SMS debe garantizar la prestación.

> **TRAMPAS DE EXAMEN**
>
> ! Dos testigos familiares (cónyuge y hermano) **invalidan** el documento.
>
> ! Comisión de Murcia: **11** (5 + 3 + 2 + 1).

A4. Igualdad entre mujeres y hombres (Ley 7/2007 de Murcia)

Ley 7/2007, de 4 de abril, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y de Protección contra la Violencia de Género en la Región de Murcia.

Concepto	Significado
Sexo / género	Diferencias biológicas / construcción sociocultural de roles
Transversalidad (mainstreaming)	Integrar la perspectiva de género en todas las fases de todas las políticas
Acción positiva	Medidas **temporales** a favor de un grupo discriminado; desaparecen al lograr la igualdad
Techo de cristal	Segregación **vertical**: barrera para llegar a puestos directivos
Suelo pegajoso	Segregación **horizontal**: concentración en sectores feminizados (cuidados, limpieza)
Evaluación de impacto de género	Informe **previo** obligatorio a cualquier disposición general

- **Instituciones**: **Instituto de la Mujer** (Ley 12/2002; tiene las funciones de **ordenación, planificación y programación** en igualdad, no el Instituto de Servicios Sociales), **Unidades de Igualdad** en cada Consejería (art. 9; elaboran el informe de impacto) y Consejo Asesor Regional de la Mujer.

- **Planes de igualdad**: el Gobierno regional aprueba **un Plan General cada legislatura**, con participación de las demás Administraciones y evaluación de su cumplimiento; las Administraciones deben presupuestar su coste.
- **Salud (art. 25)**: corregir el sesgo androcéntrico (p. ej., el **infarto en la mujer** con dolor epigástrico, fatiga y disnea). Art. 26: planes para mujeres vulnerables.
- **Género y salud**: el género crea desigualdades por sí solo y agrava las demás (renta, edad, etnia, discapacidad). Sumar el trabajo de cuidados (rol reproductivo) al empleo (rol productivo) **empeora** la salud de la mujer (doble jornada). Los hombres viven menos años y con más años perdidos por discapacidad.
- **II Plan de Igualdad del SMS (2020-2021)**: acceso al empleo, conciliación y corresponsabilidad, prevención del acoso y lenguaje inclusivo.
- **Acoso sexual**: conducta de naturaleza **sexual**. **Acoso por razón de sexo**: discriminación **por ser mujer** (p. ej., por embarazo), sin connotación sexual. Ambos son faltas muy graves.

> **TRAMPAS DE EXAMEN**
>
> ! 95% de mujeres en TCAE con salarios bajos = **suelo pegajoso**, no techo de cristal.

A5. Violencia de género en la Región de Murcia

- La violencia machista es **instrumental**: una herramienta de dominio patriarcal, no un problema de impulsos ni una enfermedad mental.
- Formas: **física** (siempre es también psicológica), **psicológica**, **sexual**, **económica** y **vicaria** (dañar a los hijos para hacer sufrir a la madre).
- **Ciclo de Lenore Walker**: **acumulación de tensión** → **explosión** → **luna de miel** (arrepentimiento), cada vez más rápido.

LO 1/2004 de Protección Integral contra la Violencia de Género (estatal)	Ley 7/2007 (Murcia)
Exige que el agresor sea o haya sido pareja	**Cualquier** agresión a la mujer por serlo (Convenio de Estambul)
Solo pareja o expareja	Incluye agresión sexual por desconocidos, acoso laboral, trata, mutilación genital

Actuación sanitaria

- Detección en AP, matronas y urgencias: somatizaciones, ansiedad, depresión, hiperfrecuentación.
- **Entrevista siempre a solas**; escucha y validación ("te creo"); evitar la victimización secundaria ("¿por qué no le dejas?").
- **Parte judicial de lesiones**: obligatorio, **de oficio** y al **Juzgado de Guardia**, aunque la mujer no quiera denunciar. Prevalece sobre el secreto profesional.
- Peligro inmediato: **112** (que avisa a las unidades policiales de familia y mujer: UFAM de la Policía Nacional, EMUME de la Guardia Civil) y acompañamiento. La **trabajadora social** coordina los recursos.
- **016**: gratuito, no aparece en la factura, pero hay que **borrarlo del registro de llamadas**. **ATENPRO** (Servicio Telefónico de Atención y Protección): dispositivo con geolocalización para mujeres con orden de protección. **AlertCops**: alerta discreta a la policía.
- **CAVI** (Centros de Atención Especializada para Mujeres Víctimas de Violencia de Género): atención psicológica, social y jurídica a mayores de 18 años **sin necesidad de denuncia**; menores solo con **consentimiento escrito de los padres**. **SAMPEX**: atención psicológica a los menores expuestos a la violencia de género.

Recursos de la Ley 7/2007 para las víctimas

- Las Administraciones dan **asistencia integral** a la mujer para paliar las consecuencias físicas y psíquicas de la violencia. Se benefician la víctima, los **menores bajo su patria potestad, guarda o tutela** y **cualquier otra persona dependiente** de ella.
- **Dispositivo de atención urgente**: asistencia inmediata, con acogida en **centros de emergencia**. Según el examen del SMS de 2022, la atención telefónica urgente en Murcia es el **112**, y las políticas de prevención las lleva la Dirección General de Mujer e Igualdad de Oportunidades, dentro de la Consejería competente.

- **Casas de acogida**: centros de **estancia media** (alojamiento, protección y apoyo psicológico, social, laboral y educativo), **no** de atención urgente.

TRAMPAS DE EXAMEN

! Agresión sexual por un desconocido: en Murcia **sí** se atiende con el protocolo de violencia de género.

! La mujer no quiere denunciar: el parte de lesiones **se emite igualmente**.

BLOQUE B · Personal estatutario: Estatuto Marco y Ley 5/2001

B1. Normas y clasificación del personal

- **TREBEP** (Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, RDLeg 5/2015): bases de todos los empleados públicos. **Estatuto Marco** (EM, Ley 55/2003): personal estatutario de los servicios de salud. **Ley 5/2001**, de 5 de diciembre, de personal estatutario del **SMS**.
- **TREBEP art. 8**: funcionarios de carrera, **interinos**, **personal laboral** (contrato) y **eventual** (confianza, cese libre). El art. 1 asimila el personal estatutario al **funcionario** (Derecho Administrativo, no laboral).
- **Personal temporal tras el RDL 12/2022** (Real Decreto-ley que reformó el Estatuto Marco): desaparece el **eventual**; solo hay **interino** y **sustituto**.

Nombramiento temporal	Causa	Límite
Interino por vacante	Plaza sin titular fijo	**3 años** (salvo proceso selectivo ya convocado)
Interino por programa temporal	Actividad coyuntural	3 años
Interino por acumulación de tareas	Exceso de actividad	**9 meses en 18 meses**
Sustituto	Vacaciones, permisos, reducción de jornada, exención de guardias	Lo que dure la causa

- **Ley 5/2001 (art. 12)**: se clasifica por titulación, funciones y carácter fijo o temporal. **Enfermería = Grupo A, subgrupo A2**. Grupo B = técnico superior de FP. C1 = bachiller o técnico (TCAE). C2 = ESO.
- Por funciones (art. 14): personal facultativo, **sanitario no facultativo** (enfermeras, matronas, fisioterapeutas) y no sanitario.

TRAMPAS DE EXAMEN

! La enfermería **no** es Grupo B: es **A2**.

! Contrato de 3 meses para la campaña de gripe: interino por **acumulación de tareas**, no "eventual".

B2. Situaciones administrativas (arts. 62-69 EM)

Situación	Claves
Servicio activo	Incluye vacaciones, permisos, **incapacidad temporal**, maternidad/paternidad y riesgos, comisión de servicios, huelga y suspensión provisional
Servicios especiales	Miembro del Gobierno, alto cargo, parlamentario, organismos internacionales > 6 meses. **Reserva de plaza**, computa antigüedad; cobra del nuevo cargo (y trienios)
Servicios bajo otro régimen	Otra entidad pública con otro vínculo. Sin reserva; computa antigüedad; reingreso preferente los 3 primeros años
Suspensión provisional	Cautelar, máx. **6 meses**, solo retribuciones básicas

Situación	Claves
Suspensión firme	Sanción; si **supera 6 meses** se **pierde el puesto**

Excedencia	Tiempo previo	Reserva de plaza	Computa	Cobra
Interés particular	**5 años**	No	No	No
Prestar servicios en el sector público	Ninguno	No (reingreso a vacante)	En el nuevo puesto	No
Cuidado de familiares (máx. 3 años)	Ninguno	**1.er año el mismo puesto** (15-18 meses si familia numerosa); luego en la localidad	**Sí**	No
Agrupación familiar	Ninguno	No	No	No
Violencia de género o terrorista	Ninguno	**6 meses** (prorrogable hasta 18)	Sí	**Íntegras los 2 primeros meses**
Forzosa	Ninguno	Primera vacante	Sí	Básicas (sueldo y trienios)

Pérdida de la condición (arts. 21-28)

Renuncia (por escrito; **no inhabilita** para volver a opositar), pérdida de nacionalidad, **jubilación**, **incapacidad permanente** (total, absoluta, gran invalidez), **separación del servicio** (inhabilita **6 años**) e inhabilitación absoluta por sentencia. Se puede **recuperar** si se recupera la nacionalidad o desaparece la incapacidad.

No existe una «excedencia por trabajar en el sector privado».

> **TRAMPAS DE EXAMEN**
>
> ! La **baja médica (IT)** es **servicio activo**.
>
> ! Interés particular exige **5 años**; agrupación familiar, ninguno.

B3. Incompatibilidades

- **Ley 53/1984 de Incompatibilidades**: no se puede tener un segundo puesto en el sector público (excepción: **profesor asociado** de Ciencias de la Salud). La actividad privada exige **autorización previa de compatibilidad**. Incumplir las incompatibilidades es **falta muy grave**.
- **Ley 1/2025, de 17 de febrero** (modifica la Ley 5/2001): el personal puede pedir **reducir su complemento específico** (renunciar a la exclusividad) para compatibilizar con la sanidad privada. **No pueden** quienes ocupen **plazas de dirección** de un servicio o unidad (jefes de servicio, supervisores).

> **TRAMPAS DE EXAMEN**
>
> ! Un supervisor de UCI que quiere trabajar en una UCI privada: **se deniega**.

B4. Derechos y deberes (arts. 17-19 EM)

- **Individuales (art. 17)**: estabilidad, retribución, **formación continuada**, **carrera profesional** (progresar sin cambiar de puesto), movilidad y promoción, salud laboral, descanso y conciliación, y **ser informado** de las funciones, tareas y objetivos de su unidad.
- **Colectivos (art. 18)**: libre sindicación, actividad sindical, **huelga** (con **servicios mínimos**), negociación colectiva y reunión.
- **Permiso para exámenes** (TREBEP art. 48): para exámenes finales y pruebas definitivas de aptitud, **durante los días de su celebración**.
- **Deberes (art. 19)**: respetar la Constitución y el Estatuto, lealtad e imparcialidad, obedecer las instrucciones, colaborar en alarma, excepción o catástrofe, **secreto profesional** (permanente, también tras la muerte del paciente o la jubilación), cumplir horarios y **mantener la formación**.

TRAMPAS DE EXAMEN

! **La formación continuada es a la vez derecho (art. 17) y deber (art. 19).**

B5. Régimen disciplinario (arts. 70-75 EM)

Falta	Ejemplos
Muy grave	No respetar la Constitución; discriminar; **quebrantar el secreto profesional** (curiosear historias); abandono del servicio con grave perjuicio; incumplir incompatibilidades; no acudir **más de 5 días** seguidos o **más de 7 faltas en 2 meses**; pedir regalos o dinero; **acoso**
Grave	Desobediencia (salvo órdenes ilegales); abandono sin grave perjuicio; grave desconsideración; negligencia grave; encubrir faltas graves; **3 días** seguidos o **3 faltas en 2 meses**; simular enfermedad o falsear el fichaje
Leve	Retraso o descuido puntual; falta de puntualidad o **1 día** sin justificar; leve desconsideración

Sanción	Para	Detalle
Separación del servicio	Solo muy graves	Pierde la condición; sin nuevo nombramiento en **6 años**
Traslado forzoso con cambio de localidad	Solo muy graves	Sin concursos para volver hasta **4 años**
Suspensión de funciones	Muy graves: **2 a 6 años** / Graves: **hasta 2 años**	Sin funciones ni sueldo
Traslado forzoso sin cambio de localidad	Graves y muy graves	Sin volver hasta **2 años**
Apercibimiento	Solo leves	**Siempre por escrito**

- **Prescripción (regla 4-2-6)**: faltas y sanciones **muy graves 4 años**, **graves 2 años**, **leves 6 meses**. Las faltas cuentan desde su comisión (las **continuadas**, desde el **último acto**); las sanciones, desde el día siguiente a su firmeza.
- **Graduación de la sanción** (TREBEP): según la **intencionalidad, descuido o negligencia**, el daño al interés público, la **reiteración o reincidencia** y el grado de participación.
- **Extinción de la responsabilidad (art. 71)**: cumplimiento, **fallecimiento**, prescripción, indulto o amnistía. La **jubilación o renuncia no la extingue**: el expediente continúa.

TRAMPAS DE EXAMEN

! **Una falta grave nunca puede sancionarse con separación del servicio.**

! El apercibimiento **verbal no existe**.

! Suspensión por falta grave: **máximo 2 años**.

Otras preguntas del test de este tema

Estas preguntas del EIR caen en el test de este tema aunque su materia es de otros apartados del programa. Aquí tienes lo necesario para responderlas.

- **Indicación enfermera** (RD 954/2015, modificado por el **RD 1302/2018**, art. 3): las enfermeras **acreditadas** pueden indicar, usar y autorizar la dispensación de **medicamentos sujetos a prescripción médica** solo **conforme a protocolos y guías** de práctica clínica (no de forma autónoma; más en los temas 6 y 22).
- **Convención sobre los Derechos del Niño** (ONU, 1989): derecho desde el nacimiento a un **nombre**, una **nacionalidad** y a conocer a sus padres; a la **educación** (primaria obligatoria y gratuita); al **descanso, el juego** y el ocio; y a la salud, con medidas que hacen hincapié en la **atención primaria**, no en la hospitalaria.